

衛教專欄 · 胰臟腫瘤

模仿之王：CA19-9 破 1000、最像胰臟癌的「自體免疫胰臟炎」

撰文・章醫師 · 閱讀時間 約 7 分鐘 · 更新 2026 年 7 月

摘要

胰臟長腫塊、黃疸、體重減輕、血糖飆升，連 CA19-9 都破 1000——這幾乎是胰臟癌的標準劇本。但有一位胰臟界的「模仿之王」——自體免疫胰臟炎（AIP），能把胰臟癌的每個特徵都模仿得維妙維肖，卻是良性、而且有特效藥（類固醇）可治的。這篇帶你看懂 CA19-9 為何不是胰臟癌專屬、AIP 與癌該怎麼分辨、及時治療與別自行停藥的重要，以及為何治療後仍要長期追蹤。核心一句話——最像胰臟癌的，不一定是胰臟癌。

01 真實故事

一位先生因為皮膚變黃、體重掉了好幾公斤來求診。影像一照，胰臟頭部腫大，抽血 CA19-9 指數更是直接衝破 1000。在場幾乎所有人心都涼了半截——這幾乎就是胰臟癌的標準劇本，家屬甚至已經在打聽要到哪裡開刀。但我沒有急著送他上手術台。因為這一切「太像癌」了，反而讓我更謹慎。我加驗了免疫指標，發現他的 IgG4 明顯升高，影像的型態也不太像典型的癌。最後診斷是——自體免疫胰臟炎（AIP）。給了類固醇之後，大約兩週，腫大就消了一半，黃疸退了、CA19-9 也一路往下掉。這顆胰臟，差一點就被冤枉切掉了。

差點被切除的胰臟

CA19-9 > 1000

標準劇本？

腫塊、黃疸、暴瘦、指數破千。
因為這是胰臟癌，準備送上手術台。

致命誤解

CA19-9 不是胰臟癌專屬。強烈發炎與
膽道阻塞，同樣能讓指數飆破千。

真相逆轉

這是一顆「太像癌」的良性發炎胰臟。

圖 差點被切除的胰臟——CA19-9 破千看似是胰臟癌的「標準劇本」，卻可能是一顆「太像癌」的良性發炎胰臟。

02 今天要回答的問題

胰臟長腫塊、黃疸、體重減輕、血糖飆升，連 CA19-9 都破 1000——這樣，一定是胰臟癌嗎？今天要介紹一位胰臟界的「模仿之王」：自體免疫胰臟炎（AIP）。它幾乎能把胰臟癌的每一個特徵都模仿得維妙維肖，卻是良性、而且有特效藥可以治的。

03 為什麼大家容易誤解？

第一個誤會，出在 CA19-9 這個指數。很多健檢報告把它標成「胰臟腫瘤指數」，害大家一看到數字高就嚇壞。但 CA19-9 其實不是胰臟專屬的——身體發炎、水泡、膽管阻塞、黃疸、肝腎功能不佳，都會讓它上升。尤其當有膽道阻塞、強烈發炎時，它甚至可能被頂到破千。第二個誤會，是以為自體免疫胰臟炎很少見、離自己很遠。事實上，它最厲害的地方就是「幾乎 100% 像」——腫塊、黃疸、血糖飆升、體重減輕，這些症狀和胰臟癌幾乎一模一樣，連經驗豐富的醫師都得步步為營。

04 醫師怎麼思考？

我常用兩句話來形容 AIP：第一，它是「最像胰臟癌」的胰臟炎；第二，它是「唯一有特效藥」可治的慢性胰臟炎。這兩句話，正好點出它為什麼危險、又為什麼幸運。它的本質是自體免疫——免疫系統誤把胰臟當敵人攻擊，戰場就在胰臟；其中一種特殊類型叫 IgG4 胰臟炎，血液或組織裡會驗到 IgG4。

所以面對一顆「很像癌」的胰臟，我不會只看 CA19-9 這一個數字，而是把免疫指標（如 IgG4）、影像的型態特徵，還有「對類固醇的反應」一起放上天平來判斷。當然，這把刀是雙面的——我同樣會非常小心，別把真正的胰臟癌誤當成自體免疫胰臟炎而延誤。所以關鍵永遠是：完整檢查、綜合判讀，而不是被單一指數牽著走。

05 最新醫學證據

自體免疫胰臟炎最令人欣慰的一點，是它有特效藥。類固醇是主要武器，起始劑量約每公斤 0.5 到 0.6 毫克，用藥大約一個月，腫脹的胰臟就能消一半以上，黃疸也跟著快速下降；只要及時診斷、及時治療，有九成以上的機會胰臟功能可以恢復。不過它有兩個特點要記住：一是復發率高，靠低劑量的類固醇維持療法，可以把復發率從約 40% 降到 20%；二是精準醫療已經派上用場——研究發現若同時帶有 CFTR 基因變異，對類固醇會特別沒效，這時就要考慮改用生物製劑 anti-CD20，也可以在一開始就考慮以生物製劑當起始治療。另外要提醒，即使治療得很好，長期仍有將近 3% 的病人會併發胰臟或淋巴等惡性腫瘤，所以務必長期追蹤。

類固醇結合精準醫學治療預測療效

類固醇治療

效果：起始劑量用藥約一個月，胰臟腫脹可消退一半以上，黃疸快速下降。

治癒率：及時診斷治療（3-6 個月內壓制發炎），90% 以上機會恢復功能。

精準醫療與防禦（警訊與替代方案）

基因變異：若帶有 CFTR 基因變異對類固醇無效 ➡ 改用生物製劑 (anti-CD20)。

⚠ 最大硬傷（復發率高達40%）：切勿自行停藥。貿然停藥可能在半年內引發不可逆的胰臟「大爆發」。

圖 類固醇結合精準醫學：用藥約一個月腫脹可消退一半以上，及時治療九成以上恢復；帶 CFTR 變異者改用 anti-CD20，復發率高達 40% 故切勿自行停藥。

06 臨床經驗分享

治療自體免疫胰臟炎，我最強調的就是一個字：「及時」。最好在 3 到 6 個月內把發炎壓下來，不要拖到九個月、一年——發炎的時間越久，胰臟越可能提早變形、萎縮、鈣化，連帶讓治療的有效率下降。第二個叮嚀是：千萬別自行停藥。治療有效後通常要用低劑量類固醇或其他調節免疫的藥物維持，很多病人一好轉就自己停，大約三到六個月後就復發；甚至有人在停藥後半年內胰臟突然「大爆發」，變成不可逆，反而得不償失。第三，自體免疫胰臟炎可能合併其他自體免疫疾病，最理想的是「雙管齊下」——由風濕免疫科醫師控制發炎的強度，胰臟科醫師負責顧胰臟功能，一邊踩煞車、一邊加油。所以，看到 CA19-9 破 1000，先別崩潰、也別大意，找對科別把它查清楚，才是正解。

雖然自體免疫胰臟炎對類固醇的效果極佳，但臨床醫學從來不是非黑即白的二分法。在我的門診裡，我經常提醒病友，即使臨床診斷高度傾向良性的自體免疫胰臟炎，如果出現以下三種關鍵狀況，為了保命，我們依然要果斷考慮外科手術：

1 高度懷疑「兩者並存」

狡猾的胰臟癌有時會與自體免疫發炎「同時出現」或「互相掩護」。若影像或切片上有任何一絲解釋不通、無法完全排除真腫瘤的疑慮，我們寧可「料敵從寬」，以手術切除確保萬無一失。

2 胰臟結構已嚴重變形

反覆的慢性發炎有時會讓胰臟內部像遭遇過風暴一樣，出現嚴重的胰管鈣化、狹窄、結石或結構扭曲。這種已經「塌陷的房子」，單靠藥物無法讓它還原重生，這時就需要透過手術治療。

3 對藥物治療反應不佳

若在使用藥物治療後，腫塊依然紋風不動、指數沒有下降，或症狀完全沒有改善，這就是身體在發出「診斷有誤」或「藥物無效」的警訊，必須立刻轉向外科手術尋求解答。

保命的底線：何時必須選擇外科手術？



高度懷疑「兩者並存」

狡猾的癌症可能與發炎同時出現、互相掩護。影像或切片若有任何無法排除真腫瘤的疑慮，料敵從寬，開刀切除。



胰臟結構已「嚴重變形」

反覆發炎導致嚴重的胰管鈣化、狹窄或結石。如同房子已塌陷，藥物無法重建，需手術介入。



對藥物治療「反應不佳」

使用類固醇後腫塊紋風不動、指數未降。這是身體發出「診斷有誤」或「藥物無效」的警訊，立刻轉向外科。

圖 保命的底線——即使高度傾向良性 AIP，出現「兩者並存疑慮」「結構嚴重變形」「對藥物反應不佳」三種狀況時，仍要果斷考慮手術。

五個重點，一次帶走

- 1 自體免疫胰臟炎是「**模仿王**」：腫塊、黃疸、血糖飆升、體重減輕，甚至 CA19-9 破 1000，都極像胰臟癌。
- 2 CA19-9 **不是胰臟癌專屬**，發炎、膽管阻塞、黃疸都會讓它上升，破千不等於一定是癌。
- 3 別只看單一數字——要合併 **IgG4、影像型態與對類固醇的反應**綜合判讀；也別把真癌誤當 AIP。
- 4 AIP 有特效藥（類固醇或 anti-CD20），及時治療九成以上可恢復；**復發率高，別自行停藥**。
- 5 即使治療良好，仍有約 **3% 併發惡性腫瘤**，需長期追蹤；理想上由風濕免疫科與胰臟科共同照護。

08 結語

面對最會模仿胰臟癌的自體免疫胰臟炎，別被一個數字嚇倒、也別掉以輕心——看清它的真面目，一顆胰臟就能免於被冤枉切除。

本文為衛教資訊，不能取代醫師診斷。診斷、用藥與追蹤計畫，請與您的胰臟專科醫師討論。

FAQ 常見問題

Q1 CA19-9 破 1000 是不是就是胰臟癌？

不一定。CA19-9 不是胰臟癌專屬，身體發炎、膽管阻塞、黃疸都會讓它大幅上升。自體免疫胰臟炎（AIP）合併膽道阻塞時，也可能把 CA19-9 頂到破千，需要進一步鑑別，不能只憑這個數字下結論。

Q2 什麼是自體免疫胰臟炎（AIP）？

AIP 是免疫系統誤把胰臟當敵人攻擊而引起的慢性胰臟炎，其中一種特殊型是 IgG4 胰臟炎。它的症狀（腫塊、黃疸、體重減輕、血糖飆升）和胰臟癌極為相似，被稱為胰臟癌的「模仿之王」。

Q3 AIP 和胰臟癌怎麼分辨？

不能只看單一數字，要綜合免疫指標（如 IgG4）、影像的型態特徵，以及對類固醇的治療反應。同時也要小心別把真正的胰臟癌誤當 AIP，需由專科醫師完整評估。

Q4 AIP 怎麼治療？會好嗎？

AIP 有特效藥，主要是類固醇，通常用藥約一個月腫脹就消一半以上，及時治療九成以上可恢復；部分對類固醇反應差者可用生物製劑 anti-CD20。但復發率高，需維持治療、切勿自行停藥。

Q5 AIP 治好後還需要追蹤嗎？

需要。即使治療效果很好，長期仍有將近 3% 的病人會併發胰臟或淋巴等惡性腫瘤，且復發率高，因此建議長期追蹤。

持續收到有溫度的胰臟衛教

訂閱電子報，並追蹤章醫師，第一時間收到新的胰臟健康專欄與衛教影片。

訂閱電子報

追蹤章醫師

上一篇

什麼是 TIGAR-O？一分鐘看懂慢性胰臟炎病因

下一篇

IgG4 相關疾病：不只是胰臟的全身性免疫問題

章醫師・胰臟健康誌

PANCREAS • HEALTH JOURNAL | 衛教資訊僅供參考，不能取代專業醫療診斷